Telemedicina en Psiquiatría en España

Requisitos y legislación vigente para el médico psiquiatra · Versión 4 auditada, con la Región de Murcia · 6 de noviembre de 2026

Telemedicina en Psiquiatría en España
- Requisitos y legislación vigente a 6 de noviembre de 2026
  - Versión 4 (auditada el 6-11-2026 contra los textos oficiales del BOE, EUR-Lex, AEPD, COP y Sanidad; incluye la Región de Murcia; adaptada al ejercicio como médico psiquiatra)
- 1. Resumen ejecutivo (lo esencial en 12 puntos)
- 2. Tus títulos: qué necesitas según dónde los obtuviste
  - 2.1 Escenario A: títulos españoles
  - 2.2 Escenario B: títulos de la UE/EEE
  - 2.3 Escenario C: títulos extracomunitarios (p. ej. Latinoamérica)
  - 2.4 Uso de la denominación "psiquiatra"
  - 2.5 Psicoterapia y tu titulación en Psicología
- 3. Autorización del centro y "lo telemático"
  - 3.1 Marco estatal
  - 3.2 Comunidades autónomas (dónde registrar la consulta telemática)
  - 3.3 Región de Murcia en detalle
- 4. Deontología y consentimiento en la videoconsulta
  - 4.1 Código de Deontología Médica 2022 (CGCOM, 17-12-2022) ✔ oficial
  - 4.2 Consentimiento informado (Ley 41/2002) ✔ oficial
  - 4.3 Ley 4/2026, de 1 de octubre (BOE 3-10-2026, en vigor 23-10-2026) ✔ oficial
  - 4.4 Buenas prácticas de la videoconsulta en salud mental
- 5. Prescripción y medicamentos en la consulta telemática
- 6. Protección de datos, web y consumo
  - 6.1 RGPD y LO 3/2018 (LOPDGDD)
  - 6.2 LSSI (Ley 34/2002) y consumo
- 7. Inteligencia artificial y software sanitario
- 8. Reglas específicas de salud mental en la videoconsulta
- 9. Pacientes fuera de España
- 10. Fiscalidad y facturación
- 11. Checklist de puesta en marcha (orden recomendado)
- 12. Fechas clave
- 13. Fuentes oficiales comprobadas en esta revisión
- 14. Pendiente de confirmar (? pendiente)
- 15. Enlaces a las fuentes oficiales

Anexo. Informe de auditoría (versiones 2 a 4)
- 1. Método
- 2. Resultado global
- 3. Corrección sustantiva
- 4. Matices añadidos
- 5. Detalle de comprobaciones
- 6. Qué no cambia
- 7. Recomendación
- 8. Adenda (versión 3): Región de Murcia
- 9. Adenda (versión 4): ejercicio como médico psiquiatra

Telemedicina en Psiquiatría en España

Requisitos y legislación vigente a 6 de noviembre de 2026

Versión 4 (auditada el 6-11-2026 contra los textos oficiales del BOE, EUR-Lex, AEPD, COP y Sanidad; incluye la Región de Murcia; adaptada al ejercicio como médico psiquiatra)

Para quién: médico especialista en Psiquiatría que ejerce en privado **como médico, no como psicólogo**, con consulta telemática (videoconsulta) y una web propia. La titulación en Psicología se trata solo como formación académica (apartado 2.5). **Alcance:** normativa estatal, autonómica, deontológica, de protección de datos, prescripción, IA y fiscalidad. No es asesoramiento jurídico; es un mapa verificado para preparar el proyecto y las consultas al colegio, a la consejería y a un abogado sanitario.

Cómo leer las marcas:

- ✓ oficial = comprobado en el texto oficial (BOE, DOGC, BOJA, CGCOM, AEPD, COP, Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid).
- ⚠ secundaria = tomado de fuentes secundarias fiables (colegios, despachos, prensa especializada); conviene confirmar antes de actuar.
- ? pendiente = no verificado o en tramitación.

---

1. Resumen ejecutivo (lo esencial en 12 puntos)

1. **No existe una ley estatal de telemedicina.** La videoconsulta se rige por la suma de: Ley 41/2002 (autonomía del paciente), Ley 44/2003 (profesiones sanitarias), RD 1277/2003 (autorización de centros), RGPD + LO 3/2018, LSSI, RD 1718/2010 (receta) y el Código de Deontología Médica 2022. ✓ oficial
2. **La telemedicina es un acto médico pleno** y el Código de Deontología 2022 (cap. XXIII, arts. 80-84) la admite si hay identificación inequívoca de las partes, confidencialidad y canal con la máxima seguridad disponible; hay que anotar en la historia clínica el medio usado, el tratamiento y las recomendaciones. ✓ oficial
3. **Hace falta un centro sanitario autorizado por la comunidad autónoma** aunque solo atiendas online (Ley 14/1986 art. 29; RD 1277/2003). La figura "consulta exclusivamente telemática" la regula cada comunidad: Cataluña ya tiene la unidad U.102 Telemedicina (con sede social inscrita), Andalucía usa el código U.900.2 Telemedicina en su formulario, y Madrid la está introduciendo en un decreto todavía no aprobado (art. 20 del proyecto). ✓ oficial ? pendiente La Región de Murcia no la prevé: su Decreto 73/2004 reproduce el catálogo estatal y exige memoria de instalaciones y visita, es decir, sede física. ✓ oficial
4. **RD 239/2026 (en vigor desde 1-7-2026)** añade el art. 7 al RD 1277/2003: el centro debe garantizar que atienden profesionales con titulación oficial y competencias adecuadas, llevar expediente actualizado de cada profesional "cualquiera que sea la modalidad y el lugar de prestación" (es decir, también telemático) y comunicarlos al REPS. Plazo para tener esa información: 1-1-2027. ✓ oficial
5. **Tus títulos condicionan todo.** Si son españoles: colegiación, REPS, seguro y alta. Si son de la UE: reconocimiento automático (médico y psiquiatra) vía RETUEX. Si son extracomunitarios: homologación del grado de Medicina (RD 889/2022) y después reconocimiento de la especialidad de Psiquiatría (RD 459/2010, con prueba teórico-práctica y prácticas; no hay reconocimiento directo). Sin el título de especialista reconocido **no puedes anunciarte ni ejercer como "psiquiatra"** (art. 16.3 LOPS; art. 90 Código 2022; art. 403 CP). ✓ oficial
6. **Ejerces como médico, no como psicólogo.** La psicoterapia forma parte de las competencias oficiales del psiquiatra (Orden PCM/205/2023) y la practicas como acto médico, bajo el Colegio de Médicos y su Código ✓ oficial. No necesitas colegiarte en el COP: la Ley 43/1979 solo exige esa colegiación "para el ejercicio de la profesión de psicólogo" ✓ oficial. Por eso no ofrezcas "servicios de psicología" ni uses "psicólogo" como denominación profesional en la web; tu titulación en Psicología puede figurar como formación académica ⚠ secundaria.
7. **Receta privada electrónica**: solo por sistema homologado en el SREP (REMPe u otros) con certificado digital de prescriptor colegiado. Psicótropos (benzodiacepinas, etc.) van en receta ordinaria; los estupefacientes de lista I pueden prescribirse electrónicamente desde el 9-12-2021 (1 medicamento por receta, máximo 4 envases/3 meses). Está prohibida la venta online de medicamentos con receta. ✓ oficial

8. **Protección de datos**: base jurídica asistencial (art. 9.2.h RGPD), registro de actividades obligatorio, evaluación de impacto si hay plataforma con historia clínica e IA, contratos de encargado con cada proveedor (vídeo, agenda, pago, hosting, IA), conservación mínima 5 años (15 en Cataluña para documentación relevante, 20 en la Región de Murcia), nada de datos clínicos por correo sin cifrar. Delegado de protección de datos obligatorio para centros sanitarios; exento el profesional que ejerce a título individual (AEPD). ✔ oficial
9. **Web**: aviso legal LSSI con colegio, número de colegiado, título y Estado de expedición, autorización sanitaria y número de registro; cookies con "rechazar" en primera capa; contratación electrónica con confirmación; desistimiento 14 días; accesibilidad (Ley 11/2023) salvo microempresa. ✔ oficial ⚠ parcial En Murcia, además, toda publicidad sanitaria (web y redes incluidas) necesita autorización previa de la Consejería y llevar el número de registro de publicidad (Decreto 7/2021). ✔ oficial Preséntate como médico especialista en Psiquiatría con tu número de colegiado (art. 90 del Código). ✔ oficial
10. **IA**: si usas chatbot o asistente, avisar de que es una IA (art. 50 Reglamento 2024/1689, aplicable desde 2-8-2026); prohibido explotar vulnerabilidades (art. 5); un cribado con finalidad diagnóstica es producto sanitario (MDR regla 11). Plazos de alto riesgo pospuestos a 2-12-2027 (anexo III) y 2-8-2028 (productos sanitarios) por el Reglamento 2026/1744. ⚠ secundaria
11. **Salud mental**: consentimiento libre e informado reforzado por la Ley 4/2026 (art. 13 bis TRLGDPD, en vigor 23-10-2026); internamiento involuntario solo en urgencia vital (art. 763 LEC, siempre presencial); menores: consentimiento de ambos progenitores y certificado de delitos sexuales si atiendes menores habitualmente; protocolo de emergencias con ubicación del paciente y teléfonos 024/112. ✔ oficial
12. **Fiscal**: IAE 832 (médicos especialistas), IVA exento (art. 20.Uno.3 LIVA, también online), factura obligatoria, Verifactu para autónomos desde 1-7-2027 (RDL 15/2025) ✔ oficial; el aplazamiento a octubre 2028 está anunciado pero pendiente de norma ⚠ secundaria.

---

2. Tus títulos: qué necesitas según dónde los obtuviste

2.1 Escenario A: títulos españoles

Paso	Norma	Detalle
Colegiación en el Colegio de Médicos del domicilio profesional principal	Ley 2/1974 art. 3; Ley 44/2003 art. 4	Colegiación única: vale para atender por vídeo a pacientes de toda España. ✔ oficial
Colegio de Psicólogos (COP): no necesario	Ley 43/1979	La colegiación en el COP es obligatoria "para el ejercicio de la profesión de psicólogo"; como ejerces como médico, no te corresponde. ✔ oficial
Inscripción en el REPS	RD 640/2014; RD 239/2026 art. 7.2	Los centros sanitarios privados inscritos en REGCESS comunican los datos de sus profesionales ✔ oficial; los colegios lo extienden a la consulta unipersonal ⚠ secundaria; el art. 7.2 del RD 1277/2003 (añadido por el RD 239/2026) lo refuerza ✔ oficial.
Seguro de responsabilidad civil	Ley 44/2003 art. 46	Obligatorio en ejercicio privado. Pide por escrito que cubra telemedicina y pacientes fuera de España (AMA limita a territorio y tribunales españoles; CCMC cubre mundo salvo EE.UU./Canadá). ✔ oficial ⚠ parcial
Certificado negativo de delitos sexuales	LO 8/2021 art. 57	Si atiendes menores de forma habitual. ✔ oficial
Alta censal 036/037	RDL 1175/1990 (tarifas del IAE)	Grupo 832 "Médicos especialistas" ✔ oficial; las personas físicas están exentas de cuota ⚠ secundaria.
RETA o Mutual Médica	Ley 2/2026 (BOE 31-7-2026)	Cuota mínima del mutualista alternativo: 86 % en 2026, 93 % en 2027 y 100 % en 2028 de la cuota RETA de referencia; pasarela voluntaria al RETA durante 1 año desde el reglamento de desarrollo ✔ oficial.

2.2 Escenario B: títulos de la UE/EEE

- Médico y psiquiatra: **reconocimiento automático** (Directiva 2005/36/CE; RD 581/2017) ante el Ministerio de Sanidad por la aplicación RETUEX (obligatoria desde 2-7-2024). Plazo para resolver según el RD 581/2017: **3 meses** en el reconocimiento automático y 4 meses en el sistema general, con recurso contra la falta de resolución ✔ oficial (la sede electrónica de Sanidad indica 4 meses ⚠ secundaria).

2.3 Escenario C: títulos extracomunitarios (p. ej. Latinoamérica)

1. **Homologación del grado de Medicina** (RD 889/2022, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, portal Valida-TE): tasa 166,50 € ⚠ secundaria; plazo legal de 6 meses con silencio negativo (art. 18.3) ✔ oficial; puede condicionarse a requisitos formativos complementarios, que deben superarse en 4 años o la homologación pierde eficacia (art. 19) ✔ oficial.
   - Situación actual: la subsede electrónica de Universidades está **cerrada desde el 22-10-2026** por incidencia técnica, con plazos suspendidos. El proyecto de nuevo real decreto (abril-mayo 2026) quedó en el aire por la disolución de las Cortes (elecciones 29-11-2026). ⚠ secundaria
2. **Reconocimiento del título de especialista en Psiquiatría** (RD 459/2010, Ministerio de Sanidad, RETUEX): requiere el grado ya homologado; no existe reconocimiento directo; el Comité de Evaluación emite informe negativo o condicionado a prácticas, formación complementaria o prueba teórico-práctica más prácticas; tras una denegación hay que esperar 2 años (art. 3.1.g); plazo de resolución de 6 meses, suspendido mientras duran la prueba, las prácticas o la formación complementaria, con silencio negativo; el periodo en prácticas no puede superar 3 meses ✔ oficial. Convocatoria 2026 de la prueba: BOE 16-2-2026. ✔ oficial
   - Alternativa: examen MIR y residencia completa de Psiquiatría (4 años).

2.4 Uso de la denominación "psiquiatra"

- Art. 16.3 Ley 44/2003: el título de especialista es necesario "para utilizar de modo expreso la denominación de especialista, para ejercer la profesión con tal carácter" en centros públicos y privados. ✔ oficial
- Art. 90 Código de Deontología 2022: los anuncios deben recoger identidad, número de colegiado y la especialidad inscrita en el Colegio; "no debe anunciarse como poseedor de una especialidad que no tiene, aunque esté capacitado para realizar actos médicos propios de la misma". ✔ oficial
- Art. 403 Código Penal (intrusismo): la STC 283/2006 limita las condenas por "especialidad", pero la sanción colegial y administrativa es real. ⚠ secundaria

2.5 Psicoterapia y tu titulación en Psicología

- El programa oficial de Psiquiatría (Orden PCM/205/2023) incluye competencias de psicoterapia: "aplicar los principios de las principales psicoterapias individuales, de pareja, de familia y de grupo". La psicoterapia que hagas es un acto médico. ✔ oficial
- La integración en el Colegio Oficial de Psicólogos es obligatoria "para el ejercicio de la profesión de psicólogo" (Ley 43/1979) ✔ oficial. Si no ofreces servicios como psicólogo, no necesitas colegiarte en el COP, ni el Máster en Psicología General Sanitaria, ni el epígrafe fiscal de psicólogo.
- En la web y en la publicidad preséntate como médico especialista en Psiquiatría, con tu número de colegiado (art. 90 del Código; art. 10 LSSI) ✔ oficial. Puedes mencionar la Licenciatura o el Grado en Psicología como formación académica; no lo presentes como un servicio ni uses "psicólogo" como denominación profesional, porque podría entenderse como ejercicio de la psicología sin colegiación ⚠ secundaria (criterio de prudencia).
- Si un día incorporas psicólogos a tu consulta: necesitarán el Máster en Psicología General Sanitaria o el título de especialista en Psicología Clínica (Ley 33/2011, DA 7.ª) ✔ oficial y su propia colegiación en el COP, y tu autorización sanitaria tendrá que incluir esa oferta asistencial (U.70 o U.900) ✔ oficial ⚠ parcial.

---

3. Autorización del centro y "lo telemático"

3.1 Marco estatal

- **Ley 14/1986 art. 29**: todo centro sanitario, "cualquiera que sea su nivel, categoría o titular", necesita autorización administrativa previa de instalación y funcionamiento. ✔ oficial
- **Ley 16/2003 arts. 26-27**: registro estatal público (REGCESS) y garantías mínimas por real decreto. ✔ oficial
- **RD 1277/2003**: clasificación. Una consulta privada de psiquiatría se encuadra como **C.2.1 Consultas médicas** con oferta asistencial **U.69 Psiquiatría** (U.103 Psiquiatría infantil y de la adolescencia; U.70 Psicología clínica; U.900 otras unidades). El catálogo estatal **no tiene unidad "telemedicina"**. ✔ oficial
- **RD 239/2026, de 25 de marzo** (BOE 26-3-2026; en vigor 1-7-2026) ✔ oficial:
   - Nuevo art. 4.2: la oferta asistencial debe ajustarse al anexo II; las CCAA pueden añadir requisitos.
   - Nuevo **art. 7 "Garantías de atención sanitaria"**: (1) atención solo por profesionales con titulación oficial y competencias de su especialidad; (2) información actualizada de todo el personal sanitario

"cualquiera que sea su vinculación jurídica y la modalidad y el lugar de prestación de los servicios", comunicación al REPS y expediente personal con titulación y especialidad; (3) informar a los nuevos profesionales de las prácticas seguras.
  - Disposición adicional 1.ª: 6 meses para tener esa información (hasta el 1-1-2027). Disposición adicional 2.ª: 1 año para que las CCAA adapten la oferta asistencial (hasta 1-7-2027).
  - No menciona la telemedicina de forma expresa; la cubre por la vía de "modalidad y lugar de prestación".
- **Publicidad**: RD 1907/1996 art. 6: la publicidad de centros debe ajustarse al contenido de la autorización; otra publicidad requiere autorización previa. Varias CCAA exigen autorización previa de publicidad sanitaria y que figure el número de registro del centro. ✓ oficial ⚠ parcial
- **Anteproyecto de Ley de Salud Digital**: consulta pública previa cerrada el 20-10-2025; en septiembre de 2026 Sanidad seguía elaborando el borrador (telemedicina, biometría, EEDS). Sin texto articulado. ? pendiente

3.2 Comunidades autónomas (dónde registrar la consulta telemática)

CCAA	Norma vigente	Telemedicina	Consulta solo online sin local
Madrid	Decreto 51/2006 (mod. Decreto 205/2023); Orden 1158/2018	Vigente: sin regulación específica. **Proyecto de decreto** (audiencia 11 a 31-3-2026; informe de la Abogacía 16-9-2026; pendiente de aprobación): art. 4 reconoce la modalidad "digital o telemática, prestada por profesionales sanitarios adscritos a un centro sanitario autorizado"; **art. 20** regula la autorización de actividad "exclusivamente digital o telemática": memoria explicativa que garantice la confidencialidad de las comunicaciones + domicilio de notificaciones en Madrid; sin planos ni equipamiento; encuadre C.2.90. ✓ oficial	Hoy: no hay figura expresa; con el nuevo decreto, sí. ? pendiente
Cataluña	Decret 151/2017	**U.102 Telemedicina** definida como prestación asistencial por TIC "con independencia de la localización"; "los servicios de telemedicina ... deben tener siempre asociada una sede social, que es la que tiene que constar en el Registro". Queda fuera del trámite simplificado de consultas. ✓ oficial	Sí, con sede social inscrita. El Govern aprobó el 3-11-2026 un nuevo decreto (declaración responsable, renovación cada 10 años) pendiente de DOGC; el proyecto llevaba la telemedicina a U.900. ⚠ secundaria
Andalucía	Decreto 69/2008; formulario actualizado por Orden 23-3-2026 (BOJA 27-3-2026)	Código **U.900.2 Telemedicina** en el formulario de solicitud. ✓ oficial	No consta regla expresa; el procedimiento pide memoria y planos. ? pendiente
Región de Murcia	Decreto 73/2004 (BORM 19-7-2004), modificado por Decreto 9/2010; Decreto 309/2010 (identificación de centros); Ley 3/2009 (derechos de los usuarios); Decreto 7/2021 (publicidad sanitaria)	Sin regla específica de telemedicina: el anexo del Decreto 73/2004 reproduce el catálogo estatal (C.2.5.11 centros de salud mental, C.2.90 otros proveedores, U.69 Psiquiatría, U.70 Psicología clínica, U.900). ✓ oficial	No prevista: la autorización de funcionamiento exige memoria con "equipamientos e infraestructuras", plantilla y posible visita de comprobación de las instalaciones, lo que presupone sede física ✓ oficial. Renovación cada 5 años ✓ oficial. Consultar al Servicio de Ordenación y Acreditación Sanitaria si admite actividad exclusivamente telemática ? pendiente. Ver detalle en 3.3.
C. Valenciana	Ley 10/2014 art. 84; Decreto 157/2014	Trámite 303 GVA; FAQ colegial remite a autorización expresa. ⚠ secundaria	? pendiente
Galicia, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Canarias	Decretos generales (12/2009, 31/2006, 49/2005, 106/2004, 68/2010)	Sin regla específica localizada. ⚠ secundaria	? pendiente

Regla práctica: la consulta se autoriza donde está tu sede (domicilio profesional); desde allí puedes atender por vídeo a pacientes de toda España. El código REGCESS del centro debe aparecer en la web.

3.3 Región de Murcia en detalle

- **Autorización sanitaria de funcionamiento** (Decreto 73/2004, art. 7) ✔ oficial: previa al inicio de la actividad y concedida para cada centro o servicio, públicos y privados "de cualquier clase y naturaleza"; las consultas privadas están sujetas desde 2004 (disposición transitoria). Sin ella: exclusión del Registro, clausura y sanción (arts. 8 y 17).
- **Documentación general** (art. 9.2) ✔ oficial: memoria descriptiva de la naturaleza del centro, con la oferta asistencial y los "equipamientos e infraestructuras necesarias"; plantilla prevista con categorías, titulaciones y régimen de dedicación, con acreditación de la titulación oficial; declaración responsable; y, si hay radiodiagnóstico, sus autorizaciones. Tasa autonómica: consultar en la sede de la CARM ⚠ secundaria.
- **Procedimiento** (arts. 10-12) ✔ oficial: informe de evaluación de los servicios técnicos con posible visita al centro; orden del Consejero de Salud; **plazo de resolución de 6 meses y silencio negativo**.
- **Renovación cada 5 años** (art. 13) ✔ oficial, a solicitud del titular, con declaración de que no han variado las condiciones y listado actualizado de la plantilla; se resuelve en 3 meses. Comunicación de cierre con 15 días de antelación (art. 14) y de modificaciones no sustanciales (art. 15) ✔ oficial.
- **Registro de Recursos Sanitarios Regionales** (arts. 18-22) ✔ oficial: inscripción de oficio tras la autorización; el centro recibe un documento acreditativo que debe exponerse al público (art. 22), desarrollado por el Decreto 309/2010 sobre identificación de centros e información a los usuarios. Órgano: Consejería de Salud, Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, Servicio de Ordenación y Acreditación Sanitaria y Calidad Asistencial (tel. 968 36 20 32). Trámites en la sede electrónica de la CARM: RES autorización, modificación y renovación; registro de publicidad sanitaria ✔ oficial.
- **Telemedicina**: no existe norma ni unidad específica. La consulta de psiquiatría se encuadra como consulta con oferta U.69 (y U.70 si hay psicólogos clínicos) desde una sede física en la Región; con esa autorización y la colegiación puedes atender por videoconsulta a pacientes de toda España ✔ oficial ⚠ parcial. Si quieres operar sin sede asistencial, pide criterio escrito a la Consejería antes de invertir ? pendiente.
- **Publicidad sanitaria (Decreto 7/2021, BORM 4-3-2021, vigente desde 4-4-2021)** ✔ oficial: toda publicidad de centros y servicios sanitarios "efectuada por cualquier medio o soporte" (web y redes incluidas) necesita **autorización previa** de la Consejería (art. 3); requisito: centro inscrito en el Registro de Recursos Sanitarios Regionales o en el de otra comunidad (art. 4); solicitud **al menos 2 meses antes** del lanzamiento, con textos, imágenes y audios (art. 6); informe del colegio profesional del responsable sanitario en 10 días (art. 8); resolución en 2 meses, **silencio positivo** (art. 9); la autorización no caduca mientras no cambie el mensaje, y cualquier cambio debe comunicarse (art. 10); el **número de registro de publicidad sanitaria debe figurar en cada anuncio** (art. 14); prohibida la publicidad de pseudoterapias y el uso de términos sanitarios por quien no es centro sanitario (art. 2); suspensión de la actividad publicitaria y sanciones de la Ley 14/1986 (arts. 15-16).
- **Derechos de los usuarios (Ley 3/2009)** ✔ oficial: consentimiento verbal como regla y escrito en procedimientos invasivos o de riesgo notorio (art. 42); contenido mínimo del documento escrito: identificación del centro, del médico, del paciente o representante y del procedimiento, lugar y fecha, firmas, apartado de revocación, constancia de que se ha comprendido la información y de que se entrega copia (art. 44); consentimiento por sustitución en incapacidad judicial, incapacidad de hecho a criterio del médico con constancia en la historia, o menor sin madurez; no cabe sustitución desde los 16 años salvo grave riesgo, en cuyo caso se informa a los padres y se tiene en cuenta su opinión (art. 46); los mayores de 16 son titulares del derecho a la información y se informa también a los mayores de 12 (art. 31.4); el profesional por cuenta propia custodia sus historias (art. 54.1) y la documentación se conserva **al menos 20 años desde el alta del último proceso asistencial** (art. 54.4); acceso del paciente con reserva de anotaciones subjetivas y datos de terceros (art. 56).
- **Colegio**: Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia (sus estatutos exigen la colegiación para ejercer "en cualquiera de sus modalidades") ⚠ secundaria. Al ejercer como médico no necesitas el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia.
- **Impacto en la web**: muestra el número de registro del centro y el número de registro de publicidad sanitaria; en Murcia, lanzar la web o una campaña sin la autorización de publicidad puede acarrear su suspensión.

---

4. Deontología y consentimiento en la videoconsulta

4.1 Código de Deontología Médica 2022 (CGCOM, 17-12-2022) ✔ oficial

- **Art. 80.1**: los medios telemáticos son conformes a la deontología "siempre que sea inequívoca la identificación de quienes intervienen, se asegure la confidencialidad y se usen vías de comunicación que garanticen la máxima seguridad disponible".
- **Art. 80.2**: registrar en la historia clínica el medio de telemedicina, el tratamiento pautado y las recomendaciones.
- **Art. 81.1-81.3**: rigen los mismos preceptos de la relación médico-paciente; el médico responde de los daños directos e indirectos; intervenciones "presididas por base científica, profesionalidad, veracidad y prudencia".
- **Art. 81.4-81.5 y 83**: redes sociales con lenguaje adecuado, sin información falsa, con identificación del autor.
- **Art. 82.1**: extremar seguridad y confidencialidad y configurar la privacidad de los medios. **Art. 82.2-82.3**: IA y bases de datos en beneficio de la sociedad; el médico se compromete con la confidencialidad, control y propiedad de los datos y con modelos que incluyan el consentimiento.
- **Art. 84**: publicidad y marca en la red sujetas al capítulo de publicidad; declarar patrocinios y conflictos de interés.
- **Arts. 85-86 (IA)**: control ético con transparencia, reversibilidad y trazabilidad; los sistemas de IA ayudan pero no sustituyen la buena práctica; nunca manipular datos.
- **Arts. 87-93 (publicidad)**: informativa, objetiva, veraz; sin falsas esperanzas, sin pacientes reales ni personas notorias como reclamo; art. 90 (identidad, colegiado, especialidad); art. 92.4 no vender fármacos al enfermo; **art. 93: es contraria a la deontología la captación de clientes con publicidad que incluya precios**.
- **Art. 17**: deber de emitir informes o certificados veraces; los de complacencia son contrarios a la deontología. Las bajas laborales (partes de IT) solo las emite el servicio público de salud o la mutua; el psiquiatra privado emite informes clínicos. ✔ oficial ⚠ parcial
- **Arts. 27-31 (secreto)**: el secreto rige "cualquiera que sea la modalidad del ejercicio"; límites en art. 31.1, entre ellos el apartado 9: cuando con el silencio se perjudique gravemente al paciente o a otras personas.
- Disposición final 2.ª: las declaraciones de la Comisión Central de Deontología aprobadas por la Asamblea son vinculantes. Relevantes: informe "La telemedicina en el acto médico" (10-6-2020) y comunicado del CGCOM de julio de 2021 sobre plataformas (médicos identificados en cada acto, la empresa debe tener relación de médicos responsables, firma electrónica de cada receta por el médico que atiende, prudencia en la prescripción a distancia). ⚠ secundaria
- Comité de Bioética de España (2023): la telemedicina es complementaria y "nunca sustituta absoluta" de la consulta presencial. ⚠ secundaria

4.2 Consentimiento informado (Ley 41/2002) ✔ oficial

- **Art. 8**: consentimiento libre y voluntario tras la información; **verbal por regla general**; escrito en intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasores y de riesgo notorio; revocable por escrito.
- **Art. 9.3-9.4**: consentimiento por representación si el paciente no es capaz a criterio del médico, si tiene capacidad modificada judicialmente o si el menor no comprende el alcance; **desde 16 años o emancipación no cabe representación**, salvo actuación de grave riesgo.
- **Art. 17**: conservar la documentación clínica como mínimo 5 años desde el alta de cada proceso; el profesional individual es responsable de su custodia (art. 17.5).
- **Art. 18.3**: el paciente accede a su historia, con la reserva de anotaciones subjetivas y datos de terceros.
- **Región de Murcia (Ley 3/2009)** ✔ oficial: mismas reglas, con contenido mínimo tasado para el consentimiento escrito (art. 44) y conservación de 20 años (art. 54.4); ver apartado 3.3.
- Recomendación práctica: documento específico de consentimiento para la modalidad telemática (identidad y ubicación, limitaciones de la videoconsulta, confidencialidad y riesgos del canal, plan ante fallo técnico, plan de emergencia y contactos, grabación si la hubiera, condiciones para pasar a presencial).

4.3 Ley 4/2026, de 1 de octubre (BOE 3-10-2026, en vigor 23-10-2026) ✔ oficial

Añade el **art. 13 bis** al texto refundido de la Ley de derechos de las personas con discapacidad: todas las intervenciones en salud mental "deberán basarse en el consentimiento libre e informado" conforme a la Ley

41/2002; decisiones con los apoyos formalmente establecidos; consultar la voluntad anticipada; en urgencia vital, art. 763 LEC con constancia en la historia de que se agotaron alternativas voluntarias; sujeciones solo excepcionales y documentadas; **prohibido el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo urgencia vital**, las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual y su uso punitivo. La disposición final 19.ª obliga al Gobierno a presentar en un año la reforma del art. 763 LEC.

4.4 Buenas prácticas de la videoconsulta en salud mental

- Tu norma deontológica vinculante es el Código de Deontología Médica (apartado 4.1). El Código Deontológico del Psicólogo no se te aplica, porque no ejerces como psicólogo. ✔ oficial
- **Guía para la práctica de la Telepsicología (Consejo General de la Psicología, 2017)**: está escrita para psicólogos, pero es la guía española más detallada sobre videoconsulta en salud mental y sirve como referencia de buena práctica ✔ oficial: al inicio verificar la identidad del paciente y del profesional (puede pedirse documento oficial a cámara), documentar la ubicación del paciente (de ella dependen el protocolo de emergencias y la ley aplicable), verificar contactos, valorar la idoneidad del paciente (capacidad cognitiva, abuso de sustancias, autolesiones, distancia a urgencias), consentimiento informado detallado al comienzo (confidencialidad y límites, plan de emergencia pactado, almacenamiento de datos, coordinación con otros profesionales, contacto entre sesiones, condiciones de derivación a presencial), entorno privado y conocer los recursos presenciales del lugar de residencia del paciente.

---

5. Prescripción y medicamentos en la consulta telemática

- **RD 1718/2010** ✔ oficial: la receta privada puede ser electrónica (art. 3); datos obligatorios del paciente (DNI/NIE en receta privada), medicamento, posología y prescriptor con número de colegiado; **art. 14**: en la receta privada electrónica se accede con el DNI electrónico del paciente (o DNI/del padre o tutor) y el certificado electrónico del prescriptor, y el sistema debe estar homologado por los consejos generales (médicos, farmacéuticos, etc.) para ser dispensable en toda España; duración máxima del tratamiento por receta 3 meses (ampliable a 6 para crónicos si lo decide la Administración, nunca para estupefacientes de lista I); en soporte electrónico, tratamientos de hasta un año con dispensaciones que no superen un mes; el farmacéutico comprueba la identidad de quien retira estupefacientes (listas I y II) y psicótropos (listas II, III y IV).
- **Sistemas homologados (SREP)**: REMPe y otras plataformas certificadas por el CGCOM; acceso gratuito a través de muchos colegios; emisión con certificado digital. ⚠ secundaria
- **Psicótropos**: alprazolam, diazepam y las demás benzodiacepinas figuran en la lista IV del anexo 1 del RD 2829/1977 ✔ oficial; se prescriben en receta ordinaria, también electrónica homologada ⚠ secundaria.
- **Estupefacientes lista I** (RD 1675/2012): receta oficial; desde el **9-12-2021** la receta electrónica emitida en un sistema homologado del SREP sirve como receta oficial de estupefacientes sin papel adicional (informe favorable de la AEMPS, art. 21.3 RD 1675/2012); 1 medicamento por receta, hasta 4 envases y 3 meses de tratamiento (art. 8); los formatos electrónicos validados sustituyen a la receta oficial en papel (art. 21). ✔ oficial
- **Venta online**: prohibida la venta por procedimientos telemáticos de medicamentos sujetos a prescripción (RDL 1/2015 art. 3.5; RD 870/2013 solo permite a farmacias vender sin receta). La web puede prescribir, nunca vender ni enviar. ✔ oficial
- **Receta transfronteriza UE** (Directiva 2011/24/UE; RD 81/2014): válida con nombre completo, fecha de nacimiento y fecha; **no se aplica a los medicamentos sujetos a receta médica especial** (art. 20.5 RD 81/2014) ✔ oficial, lo que deja fuera a los estupefacientes; la exclusión de los psicótropos la indican los colegios farmacéuticos ⚠ secundaria.
- Buena práctica: no prescribir sin valoración clínica efectiva; registrar en la historia; primera consulta online aceptable pero valorar presencialidad cuando la exploración lo exija; litio y clozapina requieren analíticas presenciales. ⚠ secundaria

---

6. Protección de datos, web y consumo

6.1 RGPD y LO 3/2018 (LOPDGDD)

- Base jurídica de la asistencia: art. 6 + **art. 9.2.h** RGPD (asistencia sanitaria) y disposición adicional 17.ª LOPDGDD; el consentimiento informado clínico y el consentimiento de datos son cosas distintas (AEPD). Consentimiento explícito separado para marketing, grabación, IA no asistencial e investigación. ✔ oficial ⚠ parcial
- **Registro de actividades de tratamiento**: obligatorio; la exención para menos de 250 empleados no se aplica si se tratan categorías especiales de datos o el tratamiento no es ocasional (art. 30.5 RGPD). ✔ oficial
- **Delegado de protección de datos (art. 34.1.l LOPDGDD)** ✔ oficial: obligatorio para "los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas"; se exceptúan los profesionales "que ejerzan su actividad a título individual". La AEPD confirma: clínicas públicas y privadas sí; profesional individual no (designación voluntaria, posible a través del colegio). Una plataforma o sociedad con varios profesionales sí necesita DPD; además, el art. 37.1.c RGPD lo exige cuando la actividad principal es el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos ✔ oficial.
- **Evaluación de impacto**: las listas de la AEPD exigen EIPD cuando concurren dos o más criterios (datos de salud, personas vulnerables, IA, gran escala...); el autónomo individual está exento salvo que concurran de forma significativa. Una plataforma con historia clínica, videoconsulta e IA debe hacerla. ✔ oficial (listas de la AEPD de los arts. 35.4 y 35.5)
- **Menores**: consentimiento de datos desde 14 años (art. 7 LOPDGDD) frente a consentimiento asistencial desde 16 (Ley 41/2002): la plataforma necesita flujos distintos para menores de 14, 14-15 y 16-17. ✔ oficial
- **Encargados del tratamiento (art. 28 RGPD)**: contrato con cada proveedor (videoconsulta, agenda, pasarela de pago, hosting, transcripción/IA). Transferencias a EE.UU. solo con empresas adheridas al Marco de Privacidad de Datos (vigente, con recurso pendiente ante el TJUE) o cláusulas tipo; preferir alojamiento en la UE. ⚠ secundaria
- **Canales**: la AEPD indica que en un centro sanitario debe evitarse enviar información sanitaria por correo electrónico o redes abiertas salvo cifrado; WhatsApp y correo ordinario quedan para avisos sin contenido clínico. ✔ oficial
- **Conservación**: mínimo 5 años (Ley 41/2002 art. 17) ✔ oficial; Cataluña, 15 años desde el alta de cada proceso para la documentación relevante (Llei 21/2000 art. 12.4) ✔ oficial; Región de Murcia, 20 años desde el alta del último proceso asistencial (Ley 3/2009 art. 54.4) ✔ oficial; nunca destruir antes (sanción de 1,2 M€ a un hospital privado en 2026 por destruir pruebas aportadas por el paciente ⚠ secundaria).
- **Grabación y transcripción con IA**: informar y obtener consentimiento explícito por sesión, revocable; proveedor con contrato art. 28 y sin reentrenamiento; validación humana del resumen; borrado del audio. ⚠ secundaria

6.2 LSSI (Ley 34/2002) y consumo

- **Aviso legal (art. 10)**: identidad, NIF, domicilio, correo; datos de la autorización sanitaria y órgano supervisor; colegio profesional y número de colegiado; título y Estado de expedición (y homologación si procede); normas deontológicas aplicables y cómo consultarlas; precios con o sin impuestos; códigos de conducta. ✔ oficial
- **Contratación electrónica (arts. 27-28)**: información previa, condiciones almacenables, confirmación de la aceptación. ✔ oficial
- **Cookies**: la guía de la AEPD exige en la primera capa un botón o mecanismo para rechazar las cookies con la misma visibilidad que el de aceptar ✔ oficial; las reglas sobre muros de cookies proceden de fuentes secundarias ⚠ secundaria.
- **Consumo (RDL 1/2007)**: desistimiento de 14 días en contratación a distancia; se pierde solo si el servicio se ejecutó por completo con consentimiento expreso previo del consumidor y sabiendo que perdería el derecho (art. 103.a). ✔ oficial
- **Accesibilidad (Ley 11/2023, aplicable desde 28-6-2025)** ✔ oficial: las microempresas que presten servicios están exentas de los requisitos de accesibilidad ✔ oficial; que una web de reserva y pago cuente como "comercio electrónico" a estos efectos es la lectura mayoritaria, no verificada en el articulado ⚠ secundaria.
- **Publicidad sanitaria**: RD 1907/1996 y normas autonómicas; artículo 93 del Código (sin precios como reclamo), art. 90 (especialidad real). ✔ oficial En la Región de Murcia, autorización previa de cada mensaje

(web y redes incluidas), solicitud 2 meses antes y número de registro de publicidad en el anuncio (Decreto 7/2021). ✔ oficial

---

7. Inteligencia artificial y software sanitario

- **Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de IA)** modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744 ("ómnibus digital sobre IA", DOUE 24-7-2026, en vigor a los tres días) ✔ oficial:
  - Desde 2-2-2025: prácticas prohibidas (art. 5) y alfabetización en IA del equipo (art. 4). Las directrices de la Comisión citan como ejemplo prohibido un chatbot terapéutico de salud mental que explote la vulnerabilidad del usuario para inducirle a comprar.
  - Desde 2-8-2026: **art. 50 transparencia**: los sistemas que interactúan con personas deben informar de que son una IA, salvo que resulte evidente ✔ oficial.
  - Desde 2-12-2026: nuevas prácticas prohibidas añadidas al art. 5 (apartados 1 bis y 1 ter) por el ómnibus ✔ oficial.
  - Alto riesgo del anexo III: 2-12-2027. IA integrada en productos sanitarios (anexo I): 2-8-2028 ✔ oficial (antes, 2-8-2026 y 2-8-2027). Obligaciones del "responsable del despliegue" (art. 26): uso según instrucciones, supervisión humana, registros, incidentes.
  - La ley española de IA caducó el 6-10-2026 con la disolución de las Cortes; el Reglamento es directamente aplicable y la AESIA ya existe.
- **Reglamento (UE) 2017/745 (MDR), anexo VIII regla 11** ✔ oficial: "los programas informáticos destinados a proporcionar información que se utiliza para tomar decisiones con fines terapéuticos o de diagnóstico se clasifican en la clase IIa" (IIb o III según la gravedad del impacto). Un cuestionario (PHQ-9, GAD-7...) con esa finalidad es producto sanitario con marcado CE; una app de bienestar sin finalidad médica no lo es ⚠ secundaria.
- **Espacio Europeo de Datos de Salud (Reglamento (UE) 2025/327)** ✔ oficial: aplicable desde 26-3-2027; desde 26-3-2029 para las categorías prioritarias a), b) y c) del art. 14.1 (resumen del paciente, receta y dispensación electrónicas) y los sistemas HCE que las tratan; desde 26-3-2031 para el resto de categorías prioritarias. Afecta también a prestadores privados ⚠ secundaria.
- Deontología: arts. 82.2-82.3 y 85-86 del Código 2022 (transparencia, reversibilidad, trazabilidad; la IA no sustituye la buena práctica). ✔ oficial

---

8. Reglas específicas de salud mental en la videoconsulta

- **Capacidad y apoyos**: Ley 8/2021 (curatela asistencial como regla) y Ley 4/2026 art. 13 bis: decisiones con los apoyos establecidos; voluntad anticipada; constancia en la historia. ✔ oficial
- **Menores**: consentimiento asistencial del menor desde 16 años (art. 9.4 Ley 41/2002); por debajo, representante legal tras oír al menor. Con patria potestad compartida, la intervención psicológica o psiquiátrica no urgente requiere el consentimiento de **ambos progenitores** (art. 156 CC: la patria potestad se ejerce conjuntamente; criterios de los colegios profesionales) ✔ oficial. Excepción verificada en el art. 156 CC: si hay sentencia o proceso penal contra un progenitor por violencia contra los hijos o contra el otro progenitor, o informe de un servicio de violencia de género, basta el consentimiento del otro para la atención psicológica de los menores, informando al primero; y **si el menor tiene más de 16 años se precisa en todo caso su consentimiento expreso** ✔ oficial. Certificado negativo de delitos sexuales (LO 8/2021 art. 57) si el contacto con menores es habitual. ✔ oficial ⚠ parcial
- **Riesgo suicida y crisis**: protocolo escrito de emergencias con ubicación confirmada del paciente, persona de contacto, teléfonos 112 y 024 (línea de atención a la conducta suicida), criterios de derivación presencial; evaluar idoneidad al inicio y en cada sesión; deber de socorro (arts. 195-196 CP) y límite del secreto por peligro grave (art. 31.1.9 del Código). ✔ oficial ⚠ parcial
- **Internamiento no voluntario (art. 763 LEC)**: exige examen judicial de la persona; no se gestiona por videoconsulta; reforma pendiente en 2027. ✔ oficial
- **No aptos o de riesgo para la modalidad telemática** (guías profesionales de telesalud mental y buenas prácticas): psicosis aguda, intoxicación, riesgo suicida alto, entorno inseguro, menores pequeños sin adulto; tratamientos con control analítico (litio, clozapina) requieren visitas presenciales periódicas. ⚠ secundaria
- No existe una ley general estatal de salud mental; el marco es la Estrategia de Salud Mental del SNS 2022-2026, el Plan de Acción 2025-2027 y el Plan de Prevención del Suicidio 2025-2027. ⚠ secundaria

9. Pacientes fuera de España

- **Directiva 2011/24/UE art. 3.d** ✔ oficial: "en el caso de la telemedicina, la asistencia sanitaria se considerará prestada en el Estado miembro donde esté establecido el prestador". El TJUE (sentencia C-115/24, "DrSmile") declara que esa regla se aplica a todos los ámbitos de la Directiva, no solo al reembolso ✔ oficial. Atendiendo desde España a pacientes de la UE, se aplica el derecho español ⚠ secundaria (interpretación).
- Matices: algunos Estados exigen registro local para dirigirse a sus pacientes; el consumidor puede demandar en su domicilio (Reglamento Bruselas I bis) si la web se dirige a ese país; fuera de la UE (Latinoamérica, EE.UU.) hay que revisar la regulación del país del paciente, las transferencias de datos y la cobertura de la póliza. ⚠ secundaria
- **Receta electrónica privada**: solo dispensable en España; receta transfronteriza UE sin psicótropos ni estupefacientes. ⚠ secundaria

10. Fiscalidad y facturación

- IVA: exención del art. 20.Uno.3 de la Ley 37/1992 para la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios en diagnóstico, prevención y tratamiento ✔ oficial; la DGT admite la exención en consultas médicas por videollamada (V0602-22) ⚠ secundaria; peritajes y formación tributan ⚠ secundaria.
- IAE grupo 832 (médicos especialistas) ✔ oficial. Retención del 15 % en facturas a empresas y profesionales; 7 % en el año de inicio de la actividad y los dos siguientes si no se ejerció actividad profesional el año anterior y se comunica al pagador (art. 95 Reglamento IRPF) ✔ oficial.
- Factura obligatoria aunque la operación esté exenta (RD 1619/2012 art. 2.1) ✔ oficial, con mención del precepto de exención ⚠ secundaria; factura simplificada hasta 400 € IVA incluido (art. 4.1) ✔ oficial.
- Factura electrónica B2B (Ley 18/2022; RD 238/2026, BOE 31-3-2026) ✔ oficial: los plazos de 1 año (más de 8 M€ de facturación) y 2 años (resto, autónomos incluidos) se cuentan desde la orden ministerial de desarrollo, publicada en octubre de 2026 según fuentes sectoriales, lo que lleva a octubre 2027 y octubre 2028 ⚠ secundaria. Solo afecta a facturas entre empresarios o profesionales. Verifactu (RD 1007/2023 modificado por RDL 15/2025): sociedades desde 1-1-2027 y resto de obligados, autónomos incluidos, desde 1-7-2027 ✔ oficial; aplazamiento a octubre 2028 anunciado el 5-10-2026, pendiente de norma ⚠ secundaria.

11. Checklist de puesta en marcha (orden recomendado)

1. Credenciales: grado de Medicina homologado o reconocido y especialidad de Psiquiatría reconocida.
2. Colegiación en el Colegio de Médicos del domicilio profesional; no necesitas el Colegio de Psicólogos.
3. Seguro de RC con cobertura expresa de telemedicina y del ámbito territorial de tus pacientes.
4. Autorización de la consulta en la consejería de tu comunidad (consulta C.2.1 + U.69; en Cataluña U.102 con sede social; en Andalucía U.900.2) y alta en REGCESS; comunica profesionales al REPS; expediente de cada profesional (RD 239/2026, antes del 1-1-2027).
5. Certificado de delitos sexuales si atenderás menores.
6. Alta censal (036), IAE 832, RETA o Mutual Médica.
7. Protección de datos: registro de actividades, EIPD, DPD si eres centro con varios profesionales, política de privacidad por capas, contratos art. 28 con cada proveedor, cifrado, doble factor, registro de accesos, procedimiento de brechas (72 h), conservación 5/15 años.
8. Plataforma de videoconsulta: identificación inequívoca (documento a cámara o certificado), cifrado, proveedor con contrato y alojamiento UE; historia clínica con campo de notas subjetivas separado y registro del medio utilizado (art. 80.2).
9. Consentimiento informado específico para la modalidad telemática y protocolo de emergencias (ubicación, contactos, 112/024, criterios de derivación).
10. Receta electrónica homologada (REMPe u otra del SREP) con certificado digital; nada de venta de medicamentos.
11. Web: aviso legal LSSI completo (colegio, número de colegiado, título y país, número de registro sanitario), cookies con rechazo en primera capa, contratación con confirmación, desistimiento, accesibilidad, publicidad

sin precios como reclamo y sin especialidades no reconocidas. En Murcia, solicita la autorización de publicidad sanitaria al menos 2 meses antes de lanzar la web o la campaña e incluye el número de registro de publicidad. Preséntate como médico especialista en Psiquiatría y no ofrezcas "servicios de psicología".

12. IA: inventario y clasificación (bienestar vs. finalidad médica), aviso "estás hablando con una IA", escalado a humano y a emergencias, sin nudges comerciales, formación del equipo (art. 4), y marcado CE si hay cribado diagnóstico.
13. Facturación: factura con mención de exención de IVA; preparar Verifactu/factura electrónica.

---

12. Fechas clave

Fecha	Qué
1-7-2026	Entrada en vigor del RD 239/2026 (art. 7 garantías de atención). ✔ oficial
2-8-2026	Art. 50 Reglamento de IA (transparencia de chatbots). ✔ oficial
2-12-2026	Nuevas prohibiciones del art. 5 del Reglamento de IA (ómnibus 2026/1744). ✔ oficial
23-10-2026	Entrada en vigor de la Ley 4/2026 (art. 13 bis salud mental). ✔ oficial
1-1-2027	Plazo para tener la información actualizada de todo el personal sanitario (DA 1.ª RD 239/2026). ✔ oficial
26-3-2027	Aplicación general del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. ✔ oficial
1-7-2027	Plazo para que las CCAA adapten la oferta asistencial (DA 2.ª RD 239/2026); Verifactu para autónomos (RDL 15/2025), salvo aplazamiento. ✔ oficial
2-12-2027	Alto riesgo anexo III del Reglamento de IA. ✔ oficial
2-8-2028	IA en productos sanitarios (anexo I). ✔ oficial
Octubre 2028	Factura electrónica B2B para autónomos (y posible nueva fecha Verifactu). ⚠ secundaria
26-3-2029	EEDS: categorías prioritarias (resumen del paciente, receta y dispensación electrónicas) y sistemas HCE. ✔ oficial
26-3-2031	EEDS: resto de categorías prioritarias (laboratorio, imagen, informes de alta). ✔ oficial

---

13. Fuentes oficiales comprobadas en esta revisión

- BOE: RD 239/2026 (BOE-A-2026-6975); RD 1277/2003 consolidado (BOE-A-2003-19572); Ley 41/2002 (BOE-A-2002-22188); LO 3/2018 (BOE-A-2018-16673); Ley 44/2003 (BOE-A-2003-21340); RD 1718/2010 (BOE-A-2011-1013); Ley 4/2026 (BOE-A-2026-20528).
- Código de Deontología Médica 2022 (CGCOM), capítulos VII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI.
- AEPD, preguntas frecuentes "Profesionales sanitarios" (FAQ 1634 sobre DPD; FAQ 1638 sobre correo electrónico).
- Consejo General de la Psicología, Guía para la práctica de la Telepsicología (2017).
- Ministerio de Sanidad, FAQ sobre reconocimiento de títulos extracomunitarios de especialista (octubre 2025).
- Comunidad de Madrid, Portal de Transparencia: proyecto de decreto de autorización y registro de centros (texto v12, arts. 4 y 20; informe de la Abogacía 16-9-2026).
- DOGC: Decret 151/2017 (U.102 Telemedicina y sede social).
- BOJA 27-3-2026: formulario del Decreto 69/2008 (U.900.2 Telemedicina).
- Consejo General de Farmacéuticos: documento informativo SREP sobre dispensación de estupefacientes (9-12-2021).
- Añadidas en la auditoría (versión 2): BOE consolidados de RD 889/2022, RD 459/2010, RD 581/2017, RD 640/2014, Ley 2/1974, Ley 43/1979, Ley 33/2011, Ley 5/2011, Orden PCM/205/2023, LO 8/2021, Ley 2/2026, Código Penal, RDL 1175/1990 (IAE), Ley 10/2014 (C. Valenciana), RD 1907/1996, Ley 14/1986, Ley 16/2003, RD 2829/1977, RD 1675/2012, RDL 1/2015, RD 870/2013, RD 81/2014, Llei 21/2000 (Cataluña), LSSI, RDL 1/2007, Ley 11/2023, Código Civil, LEC, Ley 37/1992, RD 1619/2012, RD 238/2026, RDL 15/2025, RD 439/2007; EUR-Lex: RGPD, Reglamento 2024/1689, Reglamento 2026/1744, MDR 2017/745, Reglamento 2025/327, Directiva 2011/24/UE, Directiva de ejecución 2012/52/UE, sentencia TJUE C-115/24; AEPD: guía de

cookies y listas de EIPD; COP: Código Deontológico; Sanidad: línea 024 y Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027.

- Añadidas en la versión 3 (Región de Murcia): BORM 19-7-2004 (Decreto 73/2004), BORM 21-12-2010 (Decreto 309/2010), Decreto 7/2021 (texto consolidado en Noticias Jurídicas; BORM 4-3-2021), BOE-A-2011-2493 (Ley 3/2009 consolidada), MurciaSalud (Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, listado publicado el 18-11-2025).

14. Pendiente de confirmar (? pendiente)

- Aprobación y publicación definitiva del decreto madrileño y del nuevo decreto catalán, y su tratamiento final de la consulta exclusivamente telemática.
- Texto final del Anteproyecto de Ley de Salud Digital.
- Reapertura de la sede de homologación de Universidades y el nuevo real decreto de homologación (en suspenso por las elecciones).
- Condiciones exactas de tu póliza de RC para telemedicina y pacientes en el extranjero.
- Norma que materialice el aplazamiento de Verifactu a 2028 y fecha exacta de la orden ministerial que arranca los plazos de la factura electrónica.
- Tasa de homologación (166,50 €), validez de 8 años de la autorización madrileña (Decreto 205/2023), sentencia STC 283/2006, consultas de la DGT, sanción de la AEPD a Quirón, comunicado del CGCOM de 2021, informe del Comité de Bioética de 2023, caducidad de la ley española de IA y cierre de la sede de Universidades: no accesibles desde esta sesión; siguen como ⚠ secundaria.
- Región de Murcia: si la Consejería admite autorizar una actividad exclusivamente telemática sin sede asistencial, cuantía de la tasa de autorización (sede de la CARM) y texto vigente de los estatutos del Colegio de Médicos de la Región de Murcia.

15. Enlaces a las fuentes oficiales

Estatal (BOE)

- RD 239/2026 (modifica el RD 1277/2003): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-6975
- RD 1277/2003 consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19572
- Ley 41/2002 de autonomía del paciente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
- Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
- Ley 14/1986 General de Sanidad: https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con
- Ley 16/2003 de cohesión y calidad: https://www.boe.es/eli/es/l/2003/05/28/16/con
- LO 3/2018 de protección de datos (LOPDGDD): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
- Ley 34/2002 (LSSI): https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con
- RD 1718/2010 de receta médica: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-1013
- RD 1675/2012 de recetas de estupefacientes: https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/12/14/1675/con
- RD 2829/1977 de psicótropos: https://www.boe.es/eli/es/rd/1977/10/06/2829/con
- RDL 1/2015 (Ley de garantías de los medicamentos): https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/07/24/1/con
- RD 81/2014 (asistencia transfronteriza): https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/02/07/81/con
- RD 889/2022 (homologación de títulos): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17045
- RD 459/2010 (especialistas extracomunitarios): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6960
- RD 581/2017 (cualificaciones profesionales UE): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-6586
- RD 640/2014 (REPS): https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/07/25/640/con
- Ley 2/1974 de colegios profesionales: https://www.boe.es/eli/es/l/1974/02/13/2/con
- Ley 43/1979 (Colegio Oficial de Psicólogos): https://www.boe.es/eli/es/l/1979/12/31/43/con
- Ley 33/2011 de salud pública (DA 7.ª, Psicólogo General Sanitario): https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/04/33/con
- Orden PCM/205/2023 (programa de Psiquiatría): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5700
- LO 8/2021 (protección de la infancia, art. 57): https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con

- Ley 4/2026 (discapacidad y dependencia, art. 13 bis salud mental): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-20528
- Ley 2/2026 (mutualidades alternativas): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-16653
- Código Penal: https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
- Código Civil (arts. 154 y 156): https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con
- Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 763): https://www.boe.es/eli/es/l/2000/01/07/1/con
- RDL 1/2007 (consumidores, desistimiento): https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con
- Ley 11/2023 (accesibilidad): https://www.boe.es/eli/es/l/2023/05/08/11/con
- Ley 37/1992 del IVA (art. 20.Uno.3): https://www.boe.es/eli/es/l/1992/12/28/37/con
- RD 1619/2012 (facturación): https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/11/30/1619/con
- RD 238/2026 (factura electrónica): https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/03/25/238
- RDL 15/2025 (Verifactu): https://www.boe.es/eli/es/rdl/2025/12/02/15
- RD 439/2007 (Reglamento IRPF, art. 95): https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/30/439/con
- RDL 1175/1990 (tarifas del IAE): https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1990/09/28/1175/con
- RD 1907/1996 (publicidad sanitaria): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-18085

Unión Europea (EUR-Lex)

- RGPD (UE) 2016/679: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
- Reglamento de IA (UE) 2024/1689: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R1689
- Ómnibus digital sobre IA (UE) 2026/1744: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32026R1744
- MDR (UE) 2017/745: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
- Espacio Europeo de Datos de Salud (UE) 2025/327: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32025R0327
- Directiva 2011/24/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0024
- Sentencia TJUE C-115/24 (DrSmile): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0115

Deontología, colegios y protección de datos

- Código de Deontología Médica 2022 (CGCOM): https://www.cgcom.es
- Informe de la Comisión Central de Deontología sobre telemedicina (2020): https://www.cgcom.es/notas-de-prensa/informe-de-la-comision-central-de-deontologia-en-relacion-la-telemedicina-en-el
- Guía para la práctica de la Telepsicología (COP, 2017): https://www.cop.es/pdf/telepsicologia2017.pdf
- AEPD, FAQ delegado de protección de datos en clínicas: https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/16-salud/2-profesionales-sanitarios
- AEPD, listas de tratamientos que requieren EIPD: https://www.aepd.es/documento/listas-dpia-es-35-4.pdf y https://www.aepd.es/documento/listasdpia-35.5l.pdf
- AEPD, guía de cookies: https://www.aepd.es/guias/guia-cookies.pdf
- Ministerio de Sanidad, especialistas extracomunitarios (FAQ): https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/profesiones/especialistasExtracomunitarios/home.htm
- Ministerio de Sanidad, línea 024: https://www.sanidad.gob.es/linea024/home.htm
- Homologación de títulos (Valida-TE): https://www.ciencia.gob.es/Universidades/validate.html
- Receta electrónica privada REMPe: https://rempe.es
- Consejo General de Farmacéuticos, SREP y estupefacientes: https://www.farmaceuticos.com/wp-content/uploads/2021/04/Informacion_Farmaceuticos_SREP_v2b.pdf

Comunidades autónomas

- Comunidad de Madrid, proyecto de decreto de centros sanitarios: https://www.comunidad.madrid/transparencia/proyecto-decreto-regimen-juridico-y-procedimiento-autorizacion-y-registro-centros-y-servicios
- Cataluña, Decret 151/2017 (DOGC): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639927.pdf
- Andalucía, formulario del Decreto 69/2008 (BOJA 27-3-2026): https://www.juntadeandalucia.es/boja/2026/60/29.html

- Región de Murcia, Decreto 73/2004 (BORM 19-7-2004): https://www.borm.es/services/anuncio/31094/pdf
- Región de Murcia, Decreto 309/2010 (BORM 21-12-2010): https://www.borm.es/services/anuncio/416218/pdf
- Región de Murcia, Decreto 7/2021 de publicidad sanitaria (BORM 4-3-2021): https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1391/pdf?id=791951
- Región de Murcia, Ley 3/2009 de derechos y deberes de los usuarios (BOE consolidado): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2493
- MurciaSalud, Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios: https://www.murciasalud.es/en/web/atencion-usuarios-de-servicios-sanitario/registro-de-centros-servicios-y-establecimientos-sanitarios
- Sede CARM, autorización de publicidad sanitaria: https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=605&IDTIPO=240&RASTRO=c%24m40288
- Sede CARM, Registro de centros (RES): https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=715&IDTIPO=240&RASTRO=c%24m

Anexo. Informe de auditoría (versiones 2 a 4)

Fecha: 6 de noviembre de 2026. **Objeto:** verificar una a una las afirmaciones del resumen (versión 1) contra los textos oficiales y producir la versión 2 corregida.

1. Método

- Se descargaron 50 textos oficiales (BOE consolidado, EUR-Lex, AEPD, Consejo General de la Psicología, Ministerio de Sanidad) y se extrajeron los artículos citados.
- Hosts no accesibles desde esta sesión (quedan sin verificar): ciencia.gob.es, congreso.es, Dirección General de Tributos, COP Madrid, govern.cat, isciii.es, tribunalconstitucional.es.
- Resultado posible por afirmación: **Confirmada** (coincide con el texto oficial), **Corregida** (el texto oficial dice otra cosa), **Matizada** (correcta pero incompleta; se añade el matiz) o **No verificable** (fuente inaccesible; se mantiene ⚠ **secundaria**).

2. Resultado global

Resultado	Nº
Confirmadas	44
Corregidas	1
Matizadas	5
No verificables	13

3. Corrección sustantiva

Afirmación v1	Texto oficial	Cambio en v2
Reconocimiento UE de médico y psiquiatra por RETUEX: "plazo 4 meses, silencio negativo"	RD 581/2017: el plazo para resolver es de **3 meses** y solo es de 4 meses en los casos del sistema general (capítulos I y II del título); contra la falta de resolución caben los recursos ordinarios	3 meses (automático) / 4 meses (Psicólogo General Sanitario, sistema general); la cifra de 4 meses de la sede de Sanidad se deja como ⚠ **secundaria**

4. Matices añadidos

1. **Art. 156 Código Civil**: en casos de violencia (sentencia o proceso penal contra un progenitor, o informe de servicio de violencia de género) basta el consentimiento del otro progenitor para la atención psicológica de los hijos menores, informando al primero; y los mayores de 16 años deben consentir expresamente en todo caso.
2. **Reglamento de IA (ómnibus 2026/1744)**: además de los nuevos plazos de alto riesgo (2-12-2027 y 2-8-2028), entran en vigor nuevas prohibiciones del art. 5 (apartados 1 bis y 1 ter) el 2-12-2026.
3. **EEDS (Reglamento 2025/327)**: tercera fecha, 26-3-2031, para el resto de categorías prioritarias.
4. **RD 459/2010**: plazo de resolución de 6 meses, suspendido durante prueba, prácticas o formación complementaria, con silencio negativo; prácticas de máximo 3 meses.
5. **Retención IRPF**: el 7 % no es opcional ni "para nuevos autónomos" en general: se aplica en el año de inicio y los dos siguientes si no hubo actividad profesional el año anterior y se comunica al pagador (art. 95 Reglamento IRPF).

5. Detalle de comprobaciones

#	Afirmación	Fuente verificada	Resultado
1	Homologación: plazo 6 meses y silencio negativo	RD 889/2022 art. 18.3	Confirmada

#	Afirmación	Fuente verificada	Resultado
2	Requisitos formativos complementarios, 4 años	RD 889/2022 art. 19	Confirmada
3	Tasa 166,50 €	Portal Valida-TE (inaccesible)	No verificable
4	Sede de Universidades cerrada desde 22-10-2026	ciencia.gob.es (inaccesible)	No verificable
5	Sin reconocimiento directo; informe del Comité; prueba y prácticas	FAQ Sanidad oct. 2025; RD 459/2010	Confirmada
6	2 años para volver a solicitar tras denegación	RD 459/2010 art. 3.1.g	Confirmada
7	Plazo de resolución y prácticas máx. 3 meses	RD 459/2010	Matizada (añadido)
8	Reconocimiento automático UE: 4 meses	RD 581/2017	**Corregida** (3 meses)
9	REPS: centros privados comunican profesionales	RD 640/2014 (entidades que remiten datos)	Confirmada; consulta unipersonal queda ⚠ secundaria
10	Colegiación única en el colegio del domicilio profesional	Ley 2/1974 art. 3.3	Confirmada
11	Colegiación obligatoria de psicólogos	Ley 43/1979	Confirmada
12	PGS: Máster en Psicología General Sanitaria	Ley 33/2011 DA 7.ª	Confirmada
13	Habilitación transitoria de licenciados	Ley 5/2011 DA 6.ª	Confirmada (cierre en 2014 ⚠ secundaria)
14	Psicoterapia en el programa de Psiquiatría	Orden PCM/205/2023 (competencias 4.4-4.6)	Confirmada
15	Certificado de delitos sexuales por contacto habitual con menores	LO 8/2021 art. 57	Confirmada
16	Mutualidad: 86/93/100 % y pasarela al RETA	Ley 2/2026	Confirmada
17	Arts. 195, 196, 199, 397, 403 CP	Código Penal	Confirmadas
18	STC 283/2006 limita el intrusismo de especialidad	Tribunal Constitucional (inaccesible)	No verificable
19	IAE 832 y 776	RDL 1175/1990	Confirmada
20	Autorización previa de todo centro sanitario	Ley 14/1986 art. 29; Ley 10/2014 C. Valenciana art. 84	Confirmadas
21	REGCESS y garantías mínimas	Ley 16/2003 arts. 26.2 y 27.3	Confirmada
22	Publicidad ajustada a la autorización	RD 1907/1996 art. 6	Confirmada
23	Validez de 8 años de la autorización madrileña	Decreto 205/2023 (PDF no localizado)	No verificable
24	Nuevo decreto catalán aprobado el 3-11-2026	govern.cat (inaccesible)	No verificable
25	Benzodiacepinas en lista IV	RD 2829/1977 anexo 1	Confirmada
26	Estupefacientes: 1 medicamento, 4 envases, 3 meses; formato electrónico	RD 1675/2012 arts. 8 y 21	Confirmada
27	Prohibida la venta telemática de medicamentos con receta	RDL 1/2015 art. 3.5; RD 870/2013	Confirmada
28	Receta transfronteriza excluye receta médica especial	RD 81/2014 art. 20.5	Confirmada (psicótropos ⚠ secundaria)
29	RAT obligatorio con datos de salud	RGPD art. 30.5	Confirmada
30	DPD obligatorio por tratamiento a gran escala de datos especiales	RGPD art. 37.1.c	Confirmada
31	Cataluña: 15 años de conservación	Llei 21/2000 art. 12.4	Confirmada
32	Contenido del aviso legal	LSSI art. 10	Confirmada

#	Afirmación	Fuente verificada	Resultado
33	Pérdida del desistimiento en servicios ejecutados	RDL 1/2007 art. 103.a	Confirmada
34	Accesibilidad desde 28-6-2025; microempresas de servicios exentas	Ley 11/2023	Confirmada (alcance "comercio electrónico" ⚠ secundaria)
35	Botón de rechazar cookies en primera capa	Guía AEPD de cookies	Confirmada; "muros de cookies" no localizado → ⚠ secundaria
36	EIPD con dos o más criterios; autónomo individual exento	Listas AEPD arts. 35.4 y 35.5	Confirmada
37	Código Deontológico del Psicólogo arts. 25, 40, 41, 42	COP	Confirmada
38	Art. 5.1.b (vulnerabilidades) y art. 50.1 (aviso de IA)	Reglamento 2024/1689	Confirmadas
39	Nuevos plazos de alto riesgo	Reglamento 2026/1744 art. 1	Confirmada + matiz (prohibiciones 2-12-2026)
40	Ley española de IA caducada	Congreso (inaccesible)	No verificable
41	MDR regla 11: software de decisión diagnóstica, clase IIa	Reglamento 2017/745 anexo VIII	Confirmada
42	EEDS: 26-3-2027 y 26-3-2029	Reglamento 2025/327 art. 105	Confirmada + matiz (2031)
43	Telemedicina: ley del Estado del prestador	Directiva 2011/24 art. 3.d; TJUE C-115/24 (fallo)	Confirmada
44	Consentimiento de ambos progenitores; urgencia; mayores de 16	Código Civil arts. 154 y 156	Confirmada + matiz
45	Internamiento no voluntario: examen judicial, 24/72 h	LEC art. 763	Confirmada
46	Línea 024 y Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027	Ministerio de Sanidad	Confirmadas
47	Comité de Bioética 2023 (complementariedad)	isciii.es (inaccesible)	No verificable
48	Comunicado CGCOM 2021 sobre plataformas	cgcom.es (no localizado)	No verificable
49	IVA exento, psicólogos incluidos	Ley 37/1992 art. 20.Uno.3	Confirmada
50	Consultas DGT V0602-22 y V5431-26	Tributos (inaccesible)	No verificable
51	Factura obligatoria en exentas; simplificada hasta 400 €	RD 1619/2012 arts. 2.1 y 4.1	Confirmada
52	Factura electrónica: fechas octubre 2027/2028	RD 238/2026 (plazos desde la orden ministerial)	No verificable la fecha final; mecanismo confirmado
53	Verifactu: 1-1-2027 y 1-7-2027	RDL 15/2025	Confirmada
54	Aplazamiento Verifactu a 2028	Sin norma publicada	No verificable
55	Retención 15 % / 7 %	RD 439/2007 art. 95	Matizada
56	Sanción AEPD 1,2 M€ a Quirón	Resolución no localizada	No verificable

6. Qué no cambia

Los apartados verificados en la versión 1 directamente sobre el texto oficial (RD 239/2026, RD 1277/2003, Código de Deontología Médica 2022, Ley 41/2002, LOPDGDD arts. 7 y 34, LOPS arts. 16 y 46, RD 1718/2010, Ley 4/2026, FAQ de la AEPD, Guía de Telepsicología del COP, Decret 151/2017, formulario andaluz, proyecto de decreto madrileño) se mantienen sin cambios.

7. Recomendación

Las 13 afirmaciones no verificables son secundarias (cuantías, fechas administrativas, noticias) y no alteran los requisitos; antes de tomar decisiones con ellas, confírmalas con el colegio, la consejería o el asesor fiscal. Las obligaciones esenciales (centro autorizado, colegiación y títulos, deontología, receta homologada, protección de datos, aviso legal, IA y consentimiento) quedan apoyadas en texto oficial.

8. Adenda (versión 3): Región de Murcia

Comprobaciones realizadas el 6-11-2026 sobre los textos oficiales, tras ampliar el acceso de la sesión al BORM, MurciaSalud y la sede de la CARM.

#	Afirmación	Fuente verificada	Resultado
57	Autorización previa de funcionamiento para cada centro o servicio, públicos y privados	Decreto 73/2004 art. 7 (BORM 19-7-2004)	Confirmada
58	Documentación: memoria descriptiva con oferta asistencial e infraestructuras, plantilla con titulaciones, declaración responsable	Decreto 73/2004 art. 9.2	Confirmada
59	Plazo de resolución 6 meses y silencio negativo	Decreto 73/2004 art. 12.2	Confirmada
60	Renovación cada 5 años, resuelta en 3 meses	Decreto 73/2004 art. 13	Confirmada
61	Cierre con 15 días de antelación; modificaciones no sustanciales por comunicación	Decreto 73/2004 arts. 14 y 15	Confirmada
62	Registro de Recursos Sanitarios Regionales y documento acreditativo expuesto al público	Decreto 73/2004 arts. 18-22; Decreto 309/2010 (BORM 21-12-2010)	Confirmada
63	El anexo reproduce el catálogo estatal (U.69, U.70, U.900, C.2.5.11, C.2.90) y no contiene telemedicina	Decreto 73/2004 anexo	Confirmada
64	Publicidad sanitaria: autorización previa, centro inscrito, solicitud 2 meses antes, informe colegial 10 días, resolución 2 meses con silencio positivo, número de registro en cada anuncio	Decreto 7/2021 arts. 2-16	Confirmada
65	Consentimiento verbal/escrito, contenido del documento, sustitución y 16 años	Ley 3/2009 arts. 42, 44, 46 y 31.4 (BOE-A-2011-2493)	Confirmada
66	Conservación de la historia clínica 20 años desde el alta del último proceso	Ley 3/2009 art. 54.4	Confirmada
67	Trámites RES (autorización, modificación, renovación) y publicidad en la sede de la CARM; órgano competente y teléfonos	MurciaSalud, página del Registro	Confirmada
68	Tasa de la autorización sanitaria	Sede de la CARM (página dinámica no legible)	No verificable
69	Estatutos del Colegio de Médicos de Murcia (colegiación en cualquier modalidad) y creación del Colegio de Psicología (Decreto 3/2001)	Webs colegiales no accesibles	No verificable
70	Admisión de una actividad exclusivamente telemática sin sede	Sin previsión normativa	Pendiente de consulta a la Consejería

9. Adenda (versión 4): ejercicio como médico psiquiatra

El usuario ejerce como médico, no como psicólogo. La versión 4 adapta el documento a ese perfil.

Cambio	Base verificada	Resultado
Se retiran los requisitos de ejercicio como psicólogo (Máster en Psicología General Sanitaria, homologación de títulos de Psicología, colegiación en el COP, Código Deontológico del Psicólogo, epígrafe IAE 776, buenas prácticas del COP Madrid)	Ley 43/1979: la integración en el COP es obligatoria "para el ejercicio de la profesión de psicólogo"	Confirmada
La psicoterapia del psiquiatra es un acto médico dentro de sus competencias	Orden PCM/205/2023 (competencias 4.4 a 4.6 del programa de Psiquiatría)	Confirmada

Cambio	Base verificada	Resultado
La exención de IVA se mantiene como profesional médico	Ley 37/1992 art. 20.Uno.3	Confirmada
Epígrafe fiscal: grupo 832 "Médicos especialistas"	RDL 1175/1990	Confirmada
Mencionar la titulación en Psicología solo como formación académica, sin ofrecer servicios de psicología	Interpretación prudente de la Ley 43/1979 y del art. 90 del Código de Deontología Médica	Criterio de prudencia, no norma expresa
La Guía de Telepsicología del COP (2017) se mantiene solo como referencia de buena práctica, no como norma vinculante	Código de Deontología Médica 2022, cap. XXIII	Confirmada

Las comprobaciones 11 a 13 y 37 de la sección 5 se refieren a la psicología y se conservan solo como referencia.